

PARTE V — ENCERRAMENTO

Capítulo 13

Manifesto AGIR: Uma Carta ao Meu Eu do Futuro

Eu tenho a mesma idade biológica que meus pacientes.

Isso parece óbvio, mas precisou de tempo para virar verdade vivida. Quando comecei a praticar medicina, os pacientes eram “eles” e eu era o médico — aquele que orienta, prescreve, acompanha, mas que observa o envelhecimento de um lugar diferente, como se o processo não se aplicasse a quem veste o jaleco. Levou anos para eu entender que o eixo HPA que meço nos meus pacientes também opera em mim. Que o cortisol que sobe quando Ana recebe o e-mail do chefe no domingo à noite sobe quando eu recebo a ligação do hospital no sábado de manhã. Que o sono que monitoro no Paulo com polissonografia e protocolo circadiano é o mesmo sono que eu sacrifico quando preparo uma aula de pós-graduação depois de um dia inteiro de consultório.

Sou nefrologista. Também sou professor de direito eleitoral numa pós-graduação. Também sou conselheiro fiscal. Cada uma dessas funções tem calendário próprio, pressão própria, prazo próprio. Se alguém me perguntasse, há dez anos, se eu estava cuidando de mim com a mesma diligência que cobro dos meus pacientes, a resposta honesta teria sido não.

A razão pela qual escrevo este livro — e não apenas atendo no consultório — é que esse “não” me assustou. Porque se eu, que sei exatamente o que acontece quando o sono é insuficiente, quando o treino é irregular, quando a alimentação cede à rotina e quando o estresse vira paisagem de fundo permanente — se eu sei tudo isso e ainda assim deixei a prática escapar por meses —, imagino o que acontece com quem não tem essa informação.

Este capítulo é uma carta. Não ao leitor — ao meu eu do futuro. Mas escrevo sabendo que você vai ler. E talvez se reconheça.

Ao meu eu de daqui a vinte anos:

Você vai ter por volta de setenta. Se os números que acompanho hoje continuarem na

trajetória que escolhi, suas artérias vão estar mais limpas do que as da maioria dos homens da sua idade. Sua massa muscular vai estar preservada. Sua cognição vai estar intacta — ou ao menos tão intacta quanto a biologia permitir.

Mas nada disso é garantido. É construção. E construção exige que o eu de hoje faça o trabalho que o eu de amanhã não vai poder fazer retroativamente.

Eu sei — porque vejo nos meus pacientes todo dia — que o corpo perdoa muito entre os 30 e os 45. Que os exames ficam “normais” durante anos enquanto a insulina sobe, a inflamação cresce, as placas se depositam, o sono se fragmenta, o cortisol se cronifica. Sei que a maioria das pessoas só acorda quando o corpo para de compensar — e nessa hora, o custo de reverter é dez vezes maior do que o custo de ter prevenido.

Ricardo quase morreu num estacionamento porque ninguém fez as perguntas certas a tempo. Marcos levou seis anos tomando estatina em dose baixa sem ninguém pedir um CAC — e quando o resultado veio, suas artérias tinham quase oitenta anos. Fernanda tinha quarenta e um anos e fígado gorduroso sem saber. André treinava dez horas por semana e envelhecia por dentro mais rápido do que quem não treinava. Paulo perdeu meses de progresso porque uma apneia ficou escondida atrás de um painel aparentemente bom. Ana otimizou tudo que a bioquímica permitia e ainda assim a PCR não descia — porque o que precisava de tratamento era a ansiedade que ela chamava de “personalidade”.

Eu conheço esses casos porque estive do outro lado da mesa. Mas quando fecho o consultório e vou para casa, sou paciente dos mesmos processos. O mesmo ApoB que precisa ser monitorado. O mesmo cortisol que sobe com as múltiplas demandas. O mesmo sono que precisa de regularidade que a rotina nem sempre permite. A mesma necessidade de exercício que compete com o cansaço de um dia que começou às seis e termina às vinte e três.

A diferença entre saber e fazer é o abismo que este livro tenta atravessar — não só para o leitor, mas para mim.

O que eu aprendi na prática — vendo pacientes ao longo de anos, ajustando planos, errando, corrigindo, revendo — cabe em poucas frases. São frases simples. Mas levaram uma década para virar convicção.

A primeira: **o corpo não espera pelo diagnóstico para adoecer**. A doença começa dez, quinze, vinte anos antes do rótulo. Quando a glicemia sobe, a resistência insulínica já está lá há uma década. Quando o infarto acontece, a placa já estava crescendo há duas décadas. A janela de intervenção existe — mas ela fecha. E fecha em silêncio.

A segunda: **ninguém muda tudo ao mesmo tempo**. A regra dos dois — dois focos por

trimestre, com medida e prazo — não é apenas técnica clínica. É a única forma que vi funcionar de forma sustentável, em mim e nos meus pacientes. Quem tenta mudar dez coisas na segunda-feira geralmente não mudou nenhuma na sexta. Quem escolhe duas e mantém por três meses constrói hábito. Hábito construído é trajetória modificada.

A terceira: **os pilares não funcionam isolados**. Alimentação sem sono é desgaste. Exercício sem recuperação é overtraining. Hormônio sem saúde mental é otimização sobre areia. A força do trabalho está na integração — e na humildade de reconhecer que nenhum pilar sozinho salva quando os outros estão desabando.

A quarta: **a parceria importa**. Nenhum paciente que acompanho fez sozinho. Ricardo precisou de cardiologista, de clínico, de nutricionista, de preparador físico. Ana precisou de psicóloga e psiquiatra além do clínico. Marcos precisou de um treinador que entendesse o contexto clínico. A medicina preventiva não é solilóquio de um médico iluminado — é trabalho em rede, com o paciente no centro e profissionais diferentes contribuindo com o que cada um sabe.

A quinta, e talvez a mais importante: **o melhor momento para começar era dez anos atrás. O segundo melhor é hoje**. Não é frase motivacional. É dado clínico. A reversibilidade diminui com o tempo. O custo da inação aumenta com a idade. A cada ano que passa sem monitorar, sem treinar, sem dormir direito, sem cuidar da saúde mental, o corpo deposita uma camada a mais de dano que será mais difícil de reverter depois. Mas “mais difícil” não é “impossível”. Marcos, aos 57 anos, com CAC de 412, mudou a trajetória em oito meses. Paulo, aos 48, com apneia não diagnosticada, recuperou e ultrapassou o pico de testosterona anterior em seis meses de tratamento. A idade nunca é razão para não começar. É razão para começar agora.

Ao meu eu de daqui a vinte anos: se você está lendo isto com a cabeça clara e o corpo funcional, é porque o eu de hoje fez o trabalho. Se não está — se algo cedeu, se alguma janela fechou cedo demais —, não foi por falta de saber. Foi por falta de fazer.

Ao leitor que chegou até aqui: o que acontece dentro do seu corpo nos próximos dez anos depende mais do que você faz agora do que da genética que recebeu. Você tem o mapa. Tem o método. Tem os critérios para escolher quem vai caminhar com você. O que falta é a decisão.

Ela não precisa ser dramática. Não precisa ser perfeita. Precisa ser hoje.